

요추교감신경차단 (Lumbar Sympathetic Block)

방법 · 적응증 · 효과

Lumbar Sympathetic Block / Sympatholysis — Technique, Indications, and Efficacy

구성: 개요 / 해부 → 방법 → 적응증 → 효과 → 합병증 → 결론

교육 · 연구 참고용. 개별 환자의 진료 결정은 담당 의사의 판단에 따른다. | 작성 2026-07

- LSB 와 교감신경 신경파괴 (sympatholysis) 는 70 년 이상 다양한 하지 통증 · 허혈 질환에 사용 .
 - 표적 : 신경절 밀도가 가장 높은 L2-L3(보통 'L2 하 1/3 ~ L3 상 1/3'), 척추체 전외측 . 일부 L2/L3/L4 다분절 .
 - 원리 ① : 교감신경 차단 → 혈관 확장 · 측부순환 증가 → 조직 산소화 개선 .
 - 원리 ② : 교감신경 매개 통증 (sympathetically-maintained pain) 경로 및 자율신경 동반 침해 구심로 차단 .
- 국소마취제 차단 (진단적 / 치료적) 과 화학적 / 열적 신경파괴로 나뉜다 .

방법 (Technique)

- 표준 : 방척추 (paravertebral) 접근 + 투시 (fluoroscopy). CT·초음파도 가능 .
- 바늘 진입 : 정중선에서 약 7 cm 외측 . 척추체 접촉 후 전내측으로 'walk' 하여 척추체 전외측으로 진입 .
- 흡인 후 조영제 주입 → 두미측 (craniocaudal) 종방향 확산 확인 .
- 성공 지표 : 동측 하지 피부온도 $\geq 2^{\circ}\text{C}$ 상승 .

약제

- 진단 / 치료 : lidocaine 1%,
- bupivacaine 0.25-0.5%, ropivacaine
- 신경파괴 : 무수알코올 /phenol, RFA
- 원칙 : 신경파괴는 진단적 차단 양성 시에만

적응증 (Indications)

범주	대표 적응증
통증증후군	하지 복합부위통증증후군 (CRPS I/II) — 조기 (≤ 12 개월) 시행이 유리
허혈질환	PAD· 중증 하지허혈 (CLI) 안정통· 비재건성, 버거병, 색전, 동상, 혈관연축
신경병증	당뇨병성 신경병증 / 당뇨발, 대상포진후신경통, 환상지통· 단단통
기타	족부 다한증, 레이노 증후군 (하지)· 홍색사지통증, 암성 골반 / 하지통

특발성 야간 하지경련 (NLC) 은 적응증 아님 — ' 밤 다리증상 ' 이 허혈성 안정통 (PAD/CLI) 이면 적응 . 원인 감별 (ABI· 도플러) 선행 .

효과 (1) 관류 개선 · 허혈성 통증

- 관류 실측 (Dickey 2024): LSB 후 후경골동맥 직경 0.17→0.27 cm(+58.8%), 모세혈관 재충혈 3.92→1.30 초, 족부온도 +2.8°C.
- 허혈성 통증 (PAD): 하지 통증 최대 75%↓, Fontaine 분류 · 측부관류 개선 (Medicina 2024).
- 비재건성 CLI: 교감신경 신경파괴가 절단 외 대안이 없는 환자의 통증조절에 효과적 · 안전 (Barreto 2018).

실측 수치 (Dickey 2024)

- 후경골동맥 +58.8%
- 모세혈관 재충혈 3.92→1.30 초
- 족부온도 +2.8°C
- → 관류 개선의 객관 근거

효과 (2) CRPS · 기전

- CRPS 는 교감신경 매개 통증의 전형 → LSB 후 유의한 통증완화가 축적된 근거 . 최적 환자 선택 · 조기 시행이 성공률↑ .
- Choi 2024(Sci Rep): 교감신경 신경파괴의 효과 지속기간을 전향 관찰로 제시 .
- 반응 예측 : 교감신경 피부반응 (sympathetic skin response) 이 LSB 반응 예측에 유용 (Pain Ther 2023).
- 한계 : 중추 감각이 진행되면 시간이 지날수록 효과 감소 가능 .

기전 요약 : 교감차단 → 측부순환 혈관확장 → 조직 산소화↑ → 통증↓ + 교감매개통 차단 + 신경파괴 직접효과 .

합병증 · 안전성 · 근거수준

- **합병증** : 생식대퇴신경통 (신경파괴 시 5-10%), 외측대퇴피신경 손상, 기립성 저혈압.
- 혈관 · 요관 · 신장 등 내장 구조 천공, 출혈, 신경축 (neuraxial) 확산, 신경파괴 후 통증성 신경염 (dysesthesia).
- **근거수준** : 대부분 관찰 · 증례군 · 소규모 전향연구, 대규모 RCT 는 부족 (허혈질환 · CRPS Level III~IV).

그럼에도 초기 CRPS·재건 불가능한 중증 하지허혈 (안정통) 에서 임상적으로 유용.

표준은 투시 유도 방척추 접근, 성공은 온도 $\geq 2^{\circ}\text{C}$

방법

L2-L3 방척추 접근·투시, 정중선 7 cm 외측, 조영제 두미측 확산, 성공지표 온도 $\geq 2^{\circ}\text{C}$.

약제

진단 / 치료는 국소마취제, 신경파괴는 무수알코올 /phenol·RFA — 진단차단 양성 시에만.

적응증

조기 CRPS·PAD/CLI 안정통·신경병증·다한증 등. 특발성 NLC 는 적응 아님.

효과

관류 실측 개선 (Dickey), 허혈통 최대 75%↓, CRPS 통증완화 (교감피부반응으로 예측).

근거

대규모 RCT 부족 (관찰·증례 중심). 조기 CRPS·비재건성 CLI에서 유용.

Dua A, Varacallo MA. Lumbar sympathetic block. StatPearls. 2026. NBK431107.

Lumbar sympatholysis. StatPearls. NBK560514.

Zhang JH, Deng YP, Geng MJ. Efficacy of the lumbar sympathetic ganglion block in lower limb pain. Ibrain. 2022;8(4):442-52. PMID 37786587.

Dickey Z, Sharma N. Lumbar sympathetic block leading to increased arterial diameter and blood flow. Cureus. 2024;16(6):e61755. PMID 38975506.

Barreto Junior EPS, et al. Neurolytic block of the lumbar sympathetic chain in critical lower limb ischemia. Braz J Anesthesiol. 2018;68(1):100-3. PMC9391669.

Choi EJ, et al. Effect duration of lumbar sympathetic ganglion neurolysis in CRPS. Sci Rep. 2024;14(1):12693. PMID 38830944.

Gungor S, et al. Sympathetic blocks for CRPS: a case series. Medicine (Baltimore). 2018;97(19):e0705. PMID 29742728.

Effect of lumbar sympathetic blockade on pain, Fontaine classification, collateral perfusion in PAD. Medicina (Kaunas). 2024;60(5):682.

Prediction of LSB efficacy in CRPS type 1 by sympathetic skin response. Pain Ther. 2023;12(3):809-22. PMC10199976.